

·综述·

中医外治法治疗慢性荨麻疹的研究进展

杨雯燕, 陶璐瑶, 孙庄琳, 杨怡彦, 张学易, 沈至诚, 李文惠

上海健康医学院, 上海 201318

摘要: 梳理目前关于中医外治法治疗慢性荨麻疹的相关文献, 发现主要有针灸疗法、穴位特种疗法、拔罐法、中药外用法以及组合疗法。针灸疗法包含普通针刺、电针、灸法及其他特种针具疗法, 主要通过针刺穴位以调和脏腑气血, 减轻皮肤瘙痒和损伤, 改善患者的情绪障碍和生活质量。穴位特种疗法包括穴位敷贴、穴位埋线、穴位注射等, 通过穴位刺激和药物辅助作用达到调节细胞免疫的效果。拔罐法是通过罐内负压使毛细血管扩张, 加速人体血液循环, 从而增强疗效。中药外用法包括中药熏蒸、中药外洗, 使药物成分直接被皮肤吸收, 并通过促进局部循环以减轻症状。组合疗法有针刺联合自血疗法、针灸结合刺络放血、针刺联合刺络拔罐、针刺法, 拔罐法联合刺络放血、穴位埋线加梅花针、自血穴位注射联合穴位贴敷、自血穴位注射联合穴位埋线、穴位埋线结合刺络拔罐、灸法结合脐罐法等。与西药相比, 中医外用法的组合疗法在缓解瘙痒, 改善生活质量和减少复发率上更有成效。

关键词: 慢性荨麻疹; 中医外治法; 针灸; 穴位; 拔罐; 中药外用; 综述

中图分类号: R758.24 **文献标识码:** A **DOI:** 10.16440/J.CNKI.1674-8166.2023.10.07

慢性荨麻疹是一种局限性水肿反应性皮肤病, 病程超过6周, 病情发作频繁且极易反复, 临床治愈难度很大^[1-2]。慢性荨麻疹发作时周身皮肤刺麻, 并伴随出现分布不均的风疹块, 长期发病对患者的心理健康和内分泌产生极大影响, 免疫功能也会产生相应的变化^[3]。目前对于荨麻疹的治疗分为西医和中医, 西医更局限于症状的改善, 而中医更注重“以人为本”的个性化治疗, 且不良反应更少, 也更温和。本文对中医的外治法展开综述, 覆盖了中医常用的针灸疗法, 穴位特种疗法, 拔罐法, 中医外洗法与组合疗法, 旨在为慢性荨麻疹的中医个体化治疗提出建议, 同时对各种外治法的运用进行比较。为此, 本综述囊括了目前临床上慢性荨麻疹常见的中医外治法, 现报道如下。

1 针灸疗法

针灸疗法包括针法和灸法, 针法又可分为单纯针刺疗法、电针疗法和特种针具疗法。该疗法主要通过刺激曲池、血海、足三里等穴位调和脏腑气血, 改善局部血液循环, 以缓解荨麻疹的临床症状, 较西药治疗的效果更显著, 复发率更低。

1.1 针刺疗法 通过针刺穴位可以调和脏腑气血,

减轻皮肤瘙痒和损伤的情况, 改善患者的情绪障碍和生活质量, 缓解荨麻疹导致的临床症状^[4]。武文印等^[5]选用针刺治疗慢性荨麻疹患者106例, 选取风市、翳风、秉风、风府、风门、风池行提插捻转泻法。治疗8周后针刺组总有效率显著高于口服氯雷他定的对照组(92.5%vs. 75.5%), 可见针刺治疗的疗效较西药显著。刘睿姝和王振宇^[6]选用常规盐酸西替利嗪片联合针刺治疗慢性荨麻疹患者89例, 选取风池、曲池、血海穴行平补平泻。治疗4周后联合针刺组显效率高于以常规盐酸西替利嗪片治疗的对照组(22.45%vs. 10%), 且随访8周后显效率也高于西药组(18.37%vs. 5%), 可见针刺疗法辅助治疗荨麻疹疗效显著且远期疗效稳定。王煜明等^[7]选用针刺治疗慢性荨麻疹患者29例, 治疗6周后治疗组总有效率高于口服氯雷他定片的对照组(79.3%vs. 75%), 且随访12周后治疗组的复发率远低于对照组(16.7%vs. 83%), 可见针刺治疗可以有效控制荨麻疹的复发。

针刺疗法在手法上多选择平补平泻, 穴位的选择上大多选取曲池、血海、足三里、膈俞、三阴交等, 且其中曲池-血海、曲池-足三里和血海-足三里的组合出现次数最多^[8-9]。

1.2 电针 通过电针对相应穴位进行刺激, 可以调节机体免疫反应, 降低毛细血管通透性, 缓解局部组织水肿情况和机体过敏反应, 以达到缓解荨麻疹临床症状的效果^[10-11]。彭思琦^[11]选用电针治疗慢性荨

基金项目: 上海市大学生创新创业训练项目(S202210262160)

作者简介: 杨雯燕, 大学本科在读, 研究方向: 临床医学

通信作者: 李文惠, E-mail: liwh@sumhs.edu.cn

麻疹大鼠35只,取双侧血海和曲池穴,干预治疗1周后电针组的过敏皮肤蓝斑直径小于模型组,伊文斯蓝染料渗出量少于模型组,皮下组织IgE、组胺表达量均低于模型组。刘白雪等^[12]构建大鼠荨麻疹模型,电针双侧血海穴、曲池穴1周,发现电针组较模型组皮肤致敏区域面积、皮下组织IgE表达、组胺表达均显著降低,且与口服氯雷他定组无明显差异;电针通过改善肥大细胞脱颗粒,减轻皮肤炎症浸润,达到抗过敏效果。由此可见电针对缓解荨麻疹的临床症状有较好的效果。

1.3 灸法 灸法利用灸材产生的热量扩张毛细血管,提高病变处的新陈代谢,改善病变局部的血液循环,达到调和脏腑气血、阴阳,疏通经络,祛风止痒,增强机体免疫力的效果^[13-14]。王玲等^[13]选用氯雷他定片联合三伏灸(白芥子、甘遂、细辛、玄胡)治疗慢性荨麻疹患者70例,选取双侧肺腧、脾腧、足三里、风门、天突、华盖交替治疗2年共10次后,联合治疗组总有效率高于单纯西药组(74.3%vs. 40.0%),且6个月后随访复发率也明显降低(16.67%vs. 75%)。周振红等^[14]用口服中药联合艾灸治疗慢性荨麻疹患者80例,取血海与足三里穴艾条温和灸10 min,1次/d,左右穴位隔日交替。结果发现联合艾灸组的起效时间和症状消失时间较单纯口服当归四逆汤更快,联合艾灸组总有效率升高(95.0%vs. 82.5%),复发率明显降低(2.5%vs. 15.0%)。由上述可知联合灸法对慢性荨麻疹有显著疗效。

1.4 特种针具疗法 特种针具有毫针、三棱针、皮肤针、皮内针、火针、芒针等,其中皮肤针包括梅花针、七星针和丛针等类型,此处主要介绍火针和皮肤针。火针以机械刺激和热刺激,皮肤针以反复机械刺激,均可调和经络气血,改善荨麻疹的临床症状,治疗效果较西药更好。

1.4.1 火针 火针在针灸基础上,利用被烧红针尖对局部的机械刺激、热刺激,增加人体阳气,激发经气,调节脏腑机能,改善经络气血,以治疗慢性荨麻疹^[15]。

何菊佐等^[16]选用火针配合拔罐治疗慢性荨麻疹患者62例,取阿是、血海、膈俞、曲池、合谷、风池、风市、足三里、三阴交等穴位,对照组采用普通针刺配合拔罐治疗,1次/d。治疗2周后,治疗组治愈率显著高于对照组(96.77%vs. 77.42%)。郑玉荣等^[17]选用枸地氯雷他定片联合毫火针法治疗慢性荨麻疹患者80例,火针曲池、合谷、血海、三阴交、

膈俞、足三里等穴位,3次/周。治疗4周后联合火针组的总有效率更高(94.74%vs. 70.27%),风团数量大小、瘙痒程度等荨麻疹活动度评分更低,随访1个月的复发率相比单纯西药组也明显降低(7.89%vs. 27.03%)。由此可见,火针在缓解荨麻疹临床症状以及降低复发率方面具有显著优势。

1.4.2 皮肤针 皮肤针通过对皮肤的反复叩刺,调整脏腑气血,改善经脉气血流注,调和周身气血以达到缓解荨麻疹临床症状的治疗效果^[18-19]。韩莹等^[19]选取口服氯雷他定片联合皮肤针进行治疗慢性荨麻疹患者72例。治疗3周后治疗组有效率高于对照组(91.7%vs. 66.7%)。治疗组血清IgE由14.25 mg/L降低至3.16 mg/L,而对照组由13.12 mg/L降至7.81 mg/L。邱日英^[18]采取温针灸结合梅花针叩刺治疗慢性荨麻疹患者90例,取穴风市、血海、足三里、风门、膈俞、脾俞。共治疗16次后,温针梅花针组的总有效率较温针组更高(93.33%vs. 83.33%)。可见皮肤针对荨麻疹有明显的治疗效果。

2 穴位特种疗法

穴位特种疗法包括穴位贴敷法、穴位埋线法与穴位注射法,主要选用曲池、血海、膈俞、膈俞穴和足三里等穴位以调理脏腑、祛除外邪、开通经络,同时可缓解瘙痒,减轻皮损症状,较西药治疗的疗效更显著,能有效控制病情复发,标本兼治。

2.1 穴位贴敷法 穴位贴敷兼具穴位刺激和药物疗效,通过穴位刺激调节机体阴阳,药物性味归经直接作用,并可作为“外部刺激”达到调节细胞免疫的效果^[20]。多选用祛风活血、温阳散寒类中药贴于肺俞、肾俞、神阙、血海等穴位进行治疗^[21]。吴积华和刘天骥^[22]采用中药穴位贴敷疗法治疗慢性荨麻疹患者60例,敷贴药物为黄芪、川芎、羌活、麻黄、肉桂、细辛、地龙,取神阙、曲池、风市、血海或肺俞、膈俞、脾俞、肾俞两组穴位交替使用,药末陈醋调膏外用消肿止痛贴盖贴,每次敷贴12~24 h,隔日1次,使卫阳得固、风寒得祛、营卫调和、血活疹消而顽疾得除。治疗6周后,总有效率较口服西替利嗪组更高(93.33%vs. 90%),6个月随复发率远低于西药组(9.09%vs. 30.00%)。孙兆圣和戴颖^[23]用中药贴敷法治疗慢性荨麻疹患者66例,炙黄芪、防风、浮萍、广地龙、乌梅颗粒剂以姜汁调糊贴于神阙穴,1次/d。治疗4周后总有效率高于口服玉屏风颗粒组(91.7%vs. 66.7%)。彭霞等^[24]采用中药穴位

敷贴疗法治疗慢性荨麻疹患者120例,敷贴药物为白附子、桂枝、吴茱萸、五倍子、白芥子、冰片,取肺俞、脾俞、肾俞、大椎、神阙穴位使用,药末姜汁调膏外用,每次敷贴3~6 h,1次/周,使经络疏通,固本驱邪,调和肺腑而疾病可消。治疗6周后,总有效率氯雷他定片组合穴位敷贴组更高(91.7%vs. 75.0%),6个月随访复发率远低于西药组(38.3%vs. 61.7%)。可见,中药穴位贴敷疗法治疗慢性荨麻疹能明显提高有效率,降低复发率,且具有操作简便、接受度高等优势。

2.2 穴位埋线法 穴位埋线法利用腧穴疏通经络,且对人体的刺激强度随时间而变化,使人体达到“阴平阳秘”的状态^[25]。此方法疗效确切,且疾病复发率、不良反应发生率均有所降低^[26]。阮雅敏等^[27]选用盐酸左西替利嗪口服液联合穴位埋线治疗慢性荨麻疹患者60例,以曲池、血海、膈俞、风门为基本用穴,起祛风、活血、止痒的功效。选用高分子生物合成线,优点为刺激时间及强度可控,安全性高。4周后观察组总有效率显著高于仅服用西药的对照组(93.33%vs. 73.33%),发现联合穴位埋线治疗的临床疗效明显优于单用西药的疗效。丁玲等^[25]行传统针刺法并加予运用星状神经节埋线术治疗慢性荨麻疹患者52例,选用星状神经节、风门、风市、曲池、血海与三阴交穴,每两周1次。刺激星状神经节的调节功能可产生植物分泌与内分泌功能,提高机体免疫力,疏通经络,调和气血,扶正祛邪,调和阴阳。6周后统计得到:治疗组的总有效率明显高于对照组(96.15%vs. 84.61%)。由此可见星状神经节为主埋线治疗慢性荨麻疹要优于传统单一针刺治疗。

2.3 穴位注射法 特定穴位注射将注射剂与针刺刺激与穴位渗透作用相结合,可增强药物作用疗效,更好地发挥综合效能,又可延长穴位作用时间,通过刺激机体的免疫反应,增强机体免疫力,达到消除荨麻疹症状的效果^[28-29]。荨麻疹反复发作,久病肌肤失养,腠理疏松,营卫失和,致使正气易泄,进一步加重正虚,机体气血阴阳失调,外邪也更易由疏松的腠理侵袭人体,形成正愈虚邪愈盛的恶性循环,导致病情反复。故认为慢性荨麻疹以正气不足为矛盾的主要方面,治疗时扶助正气的思想当贯穿始终^[30-31]。胡刚明等^[29]用自血疗法联合盐酸左西替利嗪片治疗慢性荨麻疹患者120例,取双侧血海穴、曲池穴、足三里各注射1 mL自体静脉血,每2 d 1次。

治疗15次后发现总有效率高于单用西药组(82.46%vs. 68.96%),随访6个月的复发率明显降低(10.0%vs. 24.6%)。自血疗法治疗慢性荨麻疹最常选用的穴位是足三里、曲池、血海、肺俞和膈俞穴,最常选用的经脉为手阳明大肠经、足阳明胃经和足太阴脾经^[32]。由此可见,穴位注射法在治疗有效率和控制复发率方面均有显著效果。

3 拔罐法

拔罐法是一种传统的外治法,常与针灸配合使用。拔罐法是通过罐内负压来使部分皮肤充血,毛细血管扩张,加速人体血液循环,使全身血脉通畅,从而增强疗效^[33]。高雪晶^[34]用神阙穴拔罐结合针刺治疗慢性荨麻疹患者60例,治疗4周后总有效率高于单纯针刺组(93.10%vs. 60.71%),复发率明显降低(8.33%vs. 25%),由此可见神阙穴拔罐结合针刺治疗慢性荨麻疹的临床效果更优,且无创,接受度高。开雁^[30]用神阙穴拔罐结合中药治疗慢性荨麻疹患者56例,采用中药结合神阙穴拔罐,达到益气固表,疏风止痒,养血活血。治疗3周后总有效率高于单纯西药组(94.6%vs. 9.3%),复发率明显降低(58.3%vs. 92.3%),由此可见神阙穴拔罐结合中药治疗更加安全,疗效更佳。

4 中药外用法

中药外用法是通过皮肤直接对药物的吸收来加强局部循环,促进体内湿气排出,从而在一定程度上缓解慢性荨麻疹的瘙痒症状,起到治疗的作用。

4.1 中药熏蒸 熏蒸法通过加热药液,使药物由蒸汽的形式被人体吸收,药物分布均匀,蒸汽的温度还可以加快血液循环,促进人体炎症物质和湿气的排出,可以缓解慢性荨麻疹导致的瘙痒。药物吸收更加快速彻底。申艳梅和夏进娥^[35]用熏蒸疗法治疗慢性荨麻疹患者62例,治疗4周后总有效率高于煎服药物组(94%vs. 78%)。刘燕婷等^[36]用熏蒸疗法治疗慢性荨麻疹患者42例,药方为防风20 g,艾叶20 g,荆芥20 g,苦参30 g,白藓皮20 g,乌蛇30 g,蛇床子20 g。治疗温度为36~43 ℃,时间20 min,1次/d。对照组口服苏迪片,10 mg/d。治疗结束(1周)后总有效率高于煎服药物组(95.24%vs. 63.33%)。由上述可知熏蒸法治疗慢性荨麻疹可以更加有利于药物的吸收,可以增强疗效。

4.2 中药外洗 中药外用直接作用于皮损部位,药

物浓度更高,皮肤吸收效果更好,通过加强局部循环减轻症状,临床上多选用桑白皮、白鲜皮、蒺藜、紫草、桃仁、赤芍等祛风止痒、清热凉血的药物,但要注意避免引起皮肤过敏^[37-38]。罗芳兰和孙月霞^[38]用中药外洗联合自血疗法治疗慢性荨麻疹患者90例,用荆芥、蒺藜、防风、红花、丹参、桃仁、赤芍等药物煎煮,温擦全身,1次/d。治疗1个月后,与单纯使用自血疗法的对照组相比,联合中药外洗组总有效率显著提高(93.33%vs. 82.22%)。由此可见,中药外洗法在慢性荨麻疹的症状上可以起到很好的缓解作用。

5 组合法

组合法是通过将具有类似作用效果的不同种类的中医法合理组合,对慢性荨麻疹进行治疗的一种治疗方法。相对于单一疗法,组合法往往可以起到提高疗效,降低不良反应发生率与复发率。

5.1 针刺联合自血疗法 彭拥军等^[39]用针刺联合自血疗法治疗慢性荨麻疹患者60例,每周3次,针刺取百会、印堂、风池、曲池、血海、足三里等穴,并每周于足三里、血海注入2 mL静脉血。10周后,与口服氯雷他定片组相比,联合疗法有效率更高(91.3%vs. 81.3%),随访1个月复发率更低(6%vs. 31.82%),且两种方法均能有效改善患者情绪及生活质量。邹宇等^[40]用针灸联合自血疗法治疗风热型慢性荨麻疹94例。针灸以双侧血海、曲池、合谷、三阴交、足三里为主穴,以双侧肺俞、外关、膈俞、脾俞、风池穴为配穴;自血疗法取双侧曲池、血海、膈俞穴位,每2 d 1次。4周后,予以针灸联合自血疗法的治疗组总有效率高于仅予自血疗法的对照组(95.74%vs. 82.98%)。综上可得,针灸联合自血疗法对慢性荨麻疹治疗效果佳,且症状明显改善,对疾病治疗有效。

5.2 针灸结合刺络放血 苏文^[41]对于18例慢性自发性荨麻疹患者进行针刺(曲池、合谷、中脘、天枢、血海、足三里、三阴交、太冲)、隔姜灸(神阙、肾俞两组穴位交替使用)结合刺络放血。6周后,治疗的总有效率为72.2%,复发率为7.69%。18例患者在治疗前后的瘙痒评分、风团数目评分、瘙痒+风团数目总评分、皮肤病生活质量指数评分各项在治疗前后比较均有不同程度下降。由此可见,针灸结合刺络放血疗法治疗慢性自发性荨麻疹,对患者的临床体征、症状以及生存质量均有明显改善,且疗效好,复发率低。

5.3 针刺联合刺络拔罐 王芸等^[42]对采用针刺治疗慢性荨麻疹患者36例,取穴风池、大椎、肺俞、膈俞、脾俞、中脘、曲池、血海和足三里,3次/周。联合组在针后对曲池、血海与大椎、肺俞两组穴位交替刺络拔罐,2次/周。治疗6周后,联合刺络拔罐组有效率明显高于单纯针刺组(94.4%vs. 66.7%),说明刺络拔罐能提高单纯针刺疗效,具有很好地临床应用价值。相文镛^[43]用梅花针叩刺联合拔罐放血治疗风热型慢性荨麻疹70例。梅花针与拔罐放血均取双侧风门与双侧血海穴,每4 d 1次。4周后,梅花针叩刺联合拔罐放血总有效率高于口服地氯雷他定片组(91.42%vs. 65.71%),随访1个月的复发率低于口服西药组(6.9%vs. 47.6%)。由上述可得梅花针联合拔罐放血对慢性荨麻疹治疗效果佳,且复发率低,对疾病控制有效。

5.4 针灸联合刺络拔罐 李梦茜^[44]用针灸联合刺络拔罐治疗慢性荨麻疹患者60例,均取双侧曲池、合谷、血海、足三里、三阴交、肺俞、膈俞与中脘、气海。治疗组采用温针灸足三里、三阴交、中脘、气海,3次/周,配合刺络拔罐肺俞、膈俞,每周1次;对照组采用常规针刺治疗,3次/周。治疗4周后治疗组总有效率高于对照组总有效率(92.9%vs. 69.0%)。由此可见,针灸联合刺络拔罐治疗在治疗慢性荨麻疹方面效果良好。

5.5 针刺法,拔罐法联合刺络放血 王楠等^[45]对慢性荨麻疹患者50例先行针刺(足三里、滑肉门、曲池、四神聪、血海、外陵),接着用拔罐(神阙穴)结合刺络放血进行治疗,4周后治疗组的总有效率高于口服抗组胺药迪皿片组(92%vs. 72%)。可知,针刺法,拔罐法联合刺络放血治疗慢性荨麻疹可以提高治疗的效果。

5.6 穴位埋线加梅花针 杨益^[46]用膻穴埋线和梅花针叩刺治疗慢性荨麻疹患者66例。治疗4周后,治疗组治疗前后风团数量、瘙痒程度、每日风团发作次数评分、风团持续时间、风团最大直径,均低于治疗前各症状评分,由此发现穴位埋线加梅花针治疗对于患者生活质量具有明显改善,且疗效明显优于口服盐酸依匹斯汀胶囊治疗。

5.7 自血穴位注射联合穴位贴敷 陈碧芳^[47]用自血穴注联合穴位贴敷方法治疗慢性荨麻疹患者64例,取双侧曲池、定喘、足三里穴交替注射1 mL静脉血,另以当归、白芍、川芎等药贴于神阙穴,每3 d 1次,共14次。治疗6周后,联合法较依巴斯汀

西药组总有效率无差异(86.67%vs. 80.00%),但愈显率明显提高(73.33%vs. 46.67%),随访1个月的复发率也明显降低(18.18%vs. 57.14%),并能提高生活质量。由此可得自血穴位注射联合穴位贴敷在治疗慢性荨麻疹方面有效。

5.8 自血穴位注射联合穴位埋线 苏可欣^[48]用自血穴位注射双侧足三里与穴位埋线双侧曲池、天枢、血海、膈俞、三阴交联合疗法治疗慢性荨麻疹患者60例,对照组则采用口服氯雷他定分散片。治疗8周后,治疗组总有效率和愈显率均高于对照组(86.67%vs. 80%, 76.67%vs. 16.67%)。3个月后治疗组复发率低于对照组(30.43%vs. 80%)。可见,自血穴位注射与穴位埋线联合疗法对慢性荨麻疹的改善程度更优,且能降低其复发率。秦二丽等^[49]对慢性荨麻疹患者1例行穴位埋线(双侧肺俞、风门、脾俞、胃俞、气海等)联合自血疗法(双侧曲池、合谷、学海、膈俞、足三里、三阴交等)治疗,每2周1次。治疗8周后,患者遇冷后不再发病。可知自血治疗联合拔罐放血对于慢性荨麻疹患者疗效佳。

5.9 自血穴位注射联合拔罐放血 王丽等^[50]对慢性荨麻疹患者1例先行自血治疗(双侧曲池、足三里、血海、三阴),次日予拔罐放血(双侧肺俞、膈俞)治疗,每隔1 d交替1次。治疗2周后,患者荨麻疹发作时风团减少,皮肤瘙痒程度减轻,遂改治疗方案为每隔2 d交替1次。治疗4周后,患者无发作。综上可知自血治疗联合拔罐放血对于患者的临床症状有明显改善,且疗效佳。

5.10 穴位埋线结合刺络拔罐 张梦珍^[51]用穴位埋线联合刺络拔罐治疗慢性荨麻疹患者60例,选取双侧肺俞、心俞、膈俞、血海、足三里埋线,结合大椎、风门、风市、委中穴位刺络拔罐,1次/周。治疗6周后,与口服氯雷他定片相比,联合法总有效率更高(93.33%vs. 86.67%),且治疗结束后3个月随访总有效率仍高于西药组(83.33%vs. 63.33%),说明穴位埋线结合刺络拔罐的远期疗效更好,且不良反应少,更为安全可靠。黄超和付勇^[52]对慢性荨麻疹患者1例行穴位埋线(关元、气海、天枢、中脘)联合刺络拔罐(大椎、肺俞、风门、膈俞、肾俞、血海、曲池)治疗,穴位均交替使用,3~5个/次,1次/周。治疗3周后,患者无瘙痒、皮肤起疹症状。随访2个月,患者未发病。由上述可知,自血治疗联合拔罐放血对于慢性荨麻疹患者控制效果好。

5.11 灸法结合脐罐法 石倩文^[53]用灸法(神阙穴、

双侧肺俞、双侧膈俞、双侧脾俞、双侧肾俞)结合脐罐法(神阙穴)治疗慢性荨麻疹患者64例,治疗4周后,结果优于口服西药组,且无复发的情况。由此可见,灸法结合脐罐法的远期疗效更好。

6 小结

荨麻疹是一种十分常见的过敏性皮肤病,其临床特征表现为表皮反复发作呈鲜红色或苍白色大小不一的风疹块,伴瘙痒或烧灼感。针灸疗法可以通过针刺穴位调节机体的免疫抗过敏反应,同时可以活血化瘀,调理患者的体质。穴位贴敷法、中药外用法都是通过皮肤外给药,通过皮肤的吸收作用达到缓解荨麻疹瘙痒的目的,避免了首关消除和药物的不良反应。穴位埋线法和自血疗法通过引起机体的非特异性免疫反应来达到调理机体阴阳平衡的效果。拔罐法则是通过压强的变化,使全身血脉通畅,从而增强疗效。中医外用法的组合疗法对比西药而言,在缓解瘙痒、改善生活质量和减少复发率方面更有成效。

相比西药而言,中药不良反应更少,对人体的伤害微乎其微,而中医外治法更是在起到治疗效果的同时,将对人体的影响降至最低,并且联合多种外治法可以增强疗效,起到个性化治疗的效果。由此可见,中医外治法在慢性荨麻疹的治疗上具有显著的成效,有光明的前景。目前慢性荨麻疹的治疗进展主要是在症状的缓解和控制方面,药物的运用可以在短时间内减轻慢性荨麻疹发作的症状,但对于长期症状的控制而言,还没有研究出最佳的中药外用的方法,而西药的定期服用会对身体产生一定的不良反应。由上述可见,中药外用法的联合运用可以起到更好的疗效,所以可以通过在联合药物的使用中更进一步研究,以发现更优组合药物并尽早投入临床。

参考文献

- [1] 杨颖. 全面护理干预对慢性荨麻疹患者治疗效果的影响[J]. 中国医药指南, 2022, 20(12):180-182.
- [2] 邹珊, 黄冬梅, 陈丽嫦. 综合护理干预对慢性荨麻疹患者的效果观察[J]. 心理月刊, 2022, 17(13):186-188.
- [3] 孙晓岩, 杨光忠, 李庆祥, 等. 慢性荨麻疹患者甲状腺激素水平、免疫功能状态与病情的相关性[J]. 海南医学院学报, 2016, 22(21):2581-2583, 2587.
- [4] 帅旷, 王钊, 金舒文, 等. 针灸治疗慢性荨麻疹的研究特点分析[J]. 辽宁中医杂志, 2021, 48(7):214-217, 262.
- [5] 武文印, 谷力彬, 杨丽丽. 针刺“治风六穴”治疗慢性荨麻疹

- 疗效观察[J]. 上海针灸杂志, 2020, 39(5):551-554.
- [6] 刘睿姝, 王振宇. 针刺治疗慢性自发性荨麻疹临床观察[J]. 现代医药卫生, 2018, 34(20):3156-3157, 3161.
- [7] 王煜明, 崔炳南, 宋坪, 等. 针刺从心论治慢性自发性荨麻疹的临床观察[J]. 中国临床医生杂志, 2018, 46(1):110-112.
- [8] 罗宏. 近5年针灸治疗慢性顽固性荨麻疹选穴规律探讨[J]. 中国民间疗法, 2022, 30(17):53-56.
- [9] 赵隽乔, 马铁明. 以针刺为主治疗慢性荨麻疹的Meta分析[J]. 针刺研究, 2020, 45(1):66-73.
- [10] 张小红. 电针调控荨麻疹大鼠肥大细胞MAPK/NF- κ B信号通路发挥抗过敏作用的实验研究[D]. 沈阳:辽宁中医药大学, 2020.
- [11] 彭思琦. 针刺曲池、血海穴对荨麻疹大鼠模型PLC γ /DAG/PKC信号通路影响的研究[D]. 沈阳:辽宁中医药大学, 2021.
- [12] 刘白雪, 李记泉, 李思佳, 等. 基于PI3K/PDK1/AKT信号通路探究电针对荨麻疹大鼠皮肤肥大细胞脱颗粒的影响[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(5):2866-2870.
- [13] 王玲, 宋佩磊, 吴伟伟, 等. 三伏灸治疗肺气虚型慢性荨麻疹疗效观察[J]. 海南医学, 2017, 28(16):2702-2703.
- [14] 周振红, 潘婉婉, 郑秀丽, 等. 中药联合热敏灸对荨麻疹的临床治疗及护理效果[J]. 延安大学学报(医学科学版), 2022, 20(2):107-109.
- [15] Fan Yu-jiang, Liu Qing-guo, Yin Gai-zhen, et al. Therapeutic Observation on Swift Needling with Fire Needle plus Medication for Herpes Zoster [J]. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 2013, 11(6):380-383.
- [16] 何菊佐, 王安平, 普天强等. 火针配合拔罐治疗荨麻疹31例[J]. 按摩与康复医学, 2017, 8(24):34-35.
- [17] 郑玉荣, 李妍慧, 董正蓉. 毫火针联合枸地氯雷他定片对血虚风燥型慢性自发性荨麻疹的临床疗效观察[J]. 按摩与康复医学, 2021, 12(18):80-83.
- [18] 邱日英. 温针灸结合梅花针治疗风寒束表型慢性荨麻疹的临床观察[D]. 广州:广州中医药大学, 2015.
- [19] 韩莹, 周钰, 刘欢, 等. 子午流注择时皮肤针疗法治疗荨麻疹临床观察[J]. 上海针灸杂志, 2018, 37(6):657-659.
- [20] 薛晴, 丛竹凤, 向泽栋, 等. 近十年中药穴位贴敷制剂研究评述[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022, 28(5):785-791.
- [21] 张莲, 刘颖. 脐疗配合电磁波治疗慢性荨麻疹的临床研究[J]. 中国中医药现代远程教育, 2016, 14(10):110-112.
- [22] 吴积华, 刘天骥. 中药穴位贴敷治疗慢性荨麻疹60例[J]. 中医外治杂志, 2016, 25(1):41.
- [23] 孙兆圣, 戴颖. 克敏脐贴治疗卫气不固型慢性荨麻疹36例疗效观察[J]. 云南中医中药杂志, 2013, 34(7):35-36.
- [24] 彭霞, 罗秋红, 王粤湘, 等. 中药穴位敷贴治疗慢性荨麻疹的疗效观察与护理[J]. 中国实用医药, 2013, 8(20):238-239.
- [25] 丁玲, 杨才德. 星状神经节为主理线治疗慢性荨麻疹临床疗效观察[C]//. 2022年中国针灸学会年会论文集. [出版者不详], 2022:54-57.
- [26] 魏锦强, 陈汉旭, 周俊德, 等. 穴位埋线治疗慢性荨麻疹疗效与安全性的系统评价[J]. 广州中医药大学学报, 2019, 36(6):861-868.
- [27] 阮雅敏, 李祥林, 杨岩, 等. 穴位埋线治疗慢性荨麻疹的临床观察[J]. 中国民间疗法, 2019, 27(15):36-37.
- [28] 胡梦婷, 葛逊, 李佩芳. 循经刺结合穴位注射治疗带状疱疹后遗神经痛的临床研究[J]. 针灸临床杂志, 2022, 38(7):10-15.
- [29] 胡刚明, 万彬彬, 张成国, 等. 穴位自血疗法联合盐酸左西替利嗪分散片治疗慢性荨麻疹临床观察[J]. 西部中医药, 2022, 35(7):95-98.
- [30] 开雁. 中药配合神阙穴拔罐治疗慢性荨麻疹56例[J]. 中国中医基础医学杂志, 2009, 15(7):560.
- [31] 景晨, 程佩, 连清. 从正气存内 邪不可干角度探讨自血疗法治疗慢性荨麻疹[J]. 中国中医药现代远程教育, 2023, 21(4):87-89.
- [32] 姜纬, 焦杨. 经络穴位介入自血疗法治疗慢性荨麻疹的选穴规律[J]. 内蒙古中医药, 2018, 37(7):88-90.
- [33] 黄丽清. 膀胱经走罐治疗慢性荨麻疹临床研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2019.
- [34] 高雪晶. 神阙穴拔罐结合针刺治疗慢性荨麻疹的临床研究[D]. 杭州:浙江中医药大学, 2019.
- [35] 申艳梅, 夏进娥. 中药熏蒸治疗慢性荨麻疹疗效观察及护理[J]. 山西医药杂志, 2015, 44(6):716-718.
- [36] 刘燕婷, 刘妍妍, 沈敏娟. 中药全身熏蒸治疗慢性荨麻疹42例[J]. 中医外治杂志, 2009, 18(1):38.
- [37] 朱建平, 田原, 鲁欣羽, 等. 国医大师张震论治慢性荨麻疹经验[J]. 中医学报, 2022, 37(8):1650-1654.
- [38] 罗芳兰, 孙月霞. 自血疗法配合中药外洗治疗荨麻疹45例[J]. 内蒙古中医药, 2016, 35(10):76-77.
- [39] 彭拥军, 王天赐, 郭琴, 等. 针刺结合自血疗法治疗慢性荨麻疹的临床疗效观察[J]. 辽宁中医药大学学报:1-8[2022-12-04].
- [40] 邹宇, 吕欣桐, 唐清体. 针灸联合自血疗法治疗慢性荨麻疹(血虚风燥型)效果及对UAS评分、外周血T淋巴细胞STAT3 mRNA表达水平的影响[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(7):1781-1784.
- [41] 苏文. 针灸结合刺络放血治疗慢性自发性荨麻疹的临床观察[D]. 北京:北京中医药大学, 2016.
- [42] 王芸, 肖佳欢, 李达, 等. 针刺配合刺络拔罐治疗慢性荨麻疹的临床研究[J]. 针灸临床杂志, 2017, 33(8):12-14.
- [43] 相文镭. 梅花针强刺激叩刺风门、血海穴(双侧)配合拔罐放血治疗风热型慢性荨麻疹的临床疗效观察[D]. 福州:福建中医药大学, 2022.
- [44] 李梦茜. 温针灸配合刺络拔罐治疗血虚风燥型慢性荨麻疹的临床研究[D]. 济南:山东中医药大学, 2022.
- [45] 王楠, 张君. 针刺、拔罐结合刺络放血治疗慢性荨麻疹的效果评价[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019(19):68-69.
- [46] 杨益. 穴位埋线加梅花针治疗胃肠湿热型慢性荨麻疹的临床观察[D]. 广州:广州中医药大学, 2019.
- [47] 陈碧芳. 自血穴注联合穴位贴敷治疗血虚风燥型慢性荨麻疹的临床疗效观察[D]. 福州:福建中医药大学, 2019.
- [48] 苏可欣. 自血穴位注射联合穴位埋线治疗胃肠湿热型慢性荨麻疹临床研究[D]. 广西:广西中医药大学, 2020.

- 药, 2020, 39(10):128–130.
- [41] 刘梦. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者穴位注射喘可治注射液临床观察[J]. 当代临床医刊, 2020, 33(3):251–252.
- [42] 李宏坤, 石芳, 孙明新, 等. 基于玄府理论探究慢性荨麻疹的针罐治疗[J]. 针灸临床杂志, 2021, 37(8):1–4.
- [43] 张明明. 通脊拔罐治疗肺肾气虚型慢性阻塞性肺疾病的临床研究[J]. 中国继续医学教育, 2015, 7(33):199–200.
- [44] 梁茜茜. 刺络拔罐对慢性阻塞性肺疾病呼吸功能障碍增效作用的临床护理观察[J]. 中国民族民间医药, 2013, 22(15):138–139.
- [45] 胡彩甜, 王敏珠, 潘志明, 等. 手部全息穴联合耳穴按压对慢性阻塞性肺疾病急性加重机械通气患者的影响[J]. 中国当代医药, 2019, 26(16):237–240.
- [46] 李艳平, 姚静松, 张立宏. 耳穴贴压对慢性阻塞性肺疾病患者无创通气后并发腹胀的疗效观察[J]. 医学综述, 2021, 27(4):829–833.
- [47] 戴曾敏, 舒健峰. 耳穴压豆联合舒利迭治疗脾肾亏虚型 COPD 稳定期患者的临床观察[J]. 中国中医药科技, 2021, 28(6):937–938.
- [48] 王鹤, 唐建清, 赵晔. 李氏铜砭刮痧在奥沙利铂所致周围神经病变中的运用[J]. 中医药导报, 2021, 27(12):188–190.
- [49] 许鸿雁. 全息经络刮痧对稳定期慢性阻塞性肺疾病患者的护理效果观察[D]. 哈尔滨:黑龙江中医药大学, 2021.
- [50] 程怡, 范良, 黄琼莲, 等. 中药足浴配合呼吸功能锻炼操在 COPD 缓解期康复治疗中的应用[J]. 中国中医急症, 2015, 24(6):1126–1128.
- [51] 侯梦星, 王晨曦, 曹心宁, 等. 益气通腑法中药灌肠联合正压无创呼吸机治疗慢性阻塞性肺疾病合并 II 型呼吸衰竭疗效观察[J]. 河北中医, 2020, 42(1):68–72.
- [52] 吴维娅, 邵丽梅, 计磊, 等. 尊重病人身心需求为导向的健康指导策略在慢性阻塞性肺疾病病人中的应用[J]. 循证护理, 2022, 8(6):843–846.
- [53] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组, 中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(3):170–205.
- [54] 陈远彬, 范斐婷, 吴蕾, 等. 培土生金中药联合西医常规疗法治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期的 Meta 分析与 GRADE 评价[J]. 中医杂志, 2021, 62(22):1970–1978.
- [55] 冯超男, 胡海殷, 季昭臣, 等. 中成药治疗慢性阻塞性肺疾病的临床研究及评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(9):2351–2357.

收稿日期: 2023–08–10 修回日期: 2023–10–08

(上接第 1471 页)

- [49] 秦二丽, 高小爱. 自血疗法联合穴位埋线治疗慢性荨麻疹验案 1 则[J]. 中国民间疗法, 2021, 29(15):106–108.
- [50] 王丽, 朱伟, 赵瑞成. 自血疗法联合拔罐放血治疗慢性荨麻疹验案 1 则[J]. 湖南中医杂志, 2023, 39(3):80–81.
- [51] 张梦珍. 穴位埋线结合刺络拔罐治疗慢性荨麻疹的临床研究[D]. 广西:广西中医药大学, 2019.
- [52] 黄超, 付勇. 穴位埋线配合刺络拔罐治疗慢性荨麻疹验案 1 则[J]. 江西中医药, 2017, 48(2):60.
- [53] 石倩文. 灸法结合脐罐法治疗慢性荨麻疹(风寒型)的临床疗效观察[D]. 长春:长春中医药大学, 2020.

收稿日期: 2023–07–21 修回日期: 2023–08–23